

monotropism-comorbidities- factcheck_es

Comorbilidades monotrópicas: verificación del encuadre de cuatro clusters

Un brief de investigación citado — verificando un encuadre ampliamente compartido de las «comorbilidades monotrópicas».

Informativo, no consejo médico. *El monotropismo es un estilo cognitivo, no un diagnóstico; no tiene «comorbilidades» en el sentido de enfermedad. Este brief evalúa qué son y qué no son los solapamientos con el encuadre de abajo. Complementa el brief paisajístico más completo del proyecto, «El monotropismo y su telaraña de comorbilidad».*

Resumen ejecutivo

- **La apertura del encuadre es exactamente correcta: el monotropismo no tiene «comorbilidades» en el sentido de enfermedad.** Es un estilo atencional en un espectro; los solapamientos con condiciones clínicas son *asociaciones y mecanismos compartidos*, no secuelas de una enfermedad [1].
- **Una afirmación estelar está al revés.** «Las personas AuDHD obtienen las puntuaciones más altas de todos los grupos en el MQ» **no** es lo que muestran los datos. En el estudio de validación del MQ, el autismo y el TDAH elevan cada uno las puntuaciones de monotropismo, pero su efecto *combinado* es una **interacción negativa** ($\beta = -0,43$, $p < ,001$): las personas autistas-con-TDAH puntúan **más bajo de lo que predeciría un modelo puramente aditivo**, no más alto [2].

- **Dos términos están correctamente atribuidos pero necesitan definiciones precisas.** La «*escisión monotrópica*» (*monotropic split*) **SÍ** está genuinamente acuñada por la defensora autista **Tanya Adkin** — pero significa el coste cognitivo de *forzar una mente monotrópica a operar de forma politrópica* (dividir la atención), **no** los «túneles AuDHD competidores» con los que a veces se confunde [3].
- **Los «problemas de permanencia del objeto» son discutidos, no establecidos.** La *única* fuente académica (Lawson & Dombroski, 2017) propone una permanencia del objeto **retrasada** como *hipótesis* para algunos estrés relacionados con el autismo — y la literatura más amplia encuentra que la permanencia del objeto es típicamente *intacta o superior* en el autismo. La experiencia de «fuera de la vista, fuera de la mente» se lee mejor como un efecto de **memoria de trabajo / asignación de la atención** [4].
- **El resto está ampliamente apoyado pero graduado por la evidencia.** El autismo (fundacional), la hiperfocalización del TDAH (real), el solapamiento ansiedad/rumiación y TOC (robusto), la inercia autista (real), el abrumamiento sensorial → meltdown/shutdown (real), y el burnout por transiciones forzadas + enmascaramiento (constructo establecido) sobreviven todos al escrutinio — siendo la hiper-sistematización la **teoría E-S separada de Baron-Cohen**, no un hallazgo del monotropismo [5].
- **Un reencuadre neuroafirmativo:** cada solapamiento se enuncia mejor como «*cómo interactúa un sistema de atención estrecho e intenso con un mundo politrópico*» en lugar de como una lista de trastornos que un cerebro monotrópico «causa».

1. El principio central (el encuadre acierta en esto)

El monotropismo (Murray, Lawson & Lesser, 2005) sostiene que las mentes difieren en *cómo asignan la atención*: una mente monotrópica concentra recursos en pocos «túneles de atención» intensamente activados; una mente politrópica los reparte entre muchos [1]. Como es un **estilo cognitivo dimensional** — medible en el Monotropism Questionnaire (MQ) en una escala 1–5 — no «tiene comorbilidades». Lo que *tiene* son **asociaciones estadísticas** (grupos que puntúan más alto) y

mecanismos compartidos (condiciones cuyas características una lente de asignación de la atención ayuda a explicar). Mantener esa distinción es todo el juego [1][2].

Este brief está organizado como una **verificación afirmación por afirmación** del encuadre de cuatro clusters, graduando cada elemento. Complementa (no repite) el brief paisajístico existente del proyecto, que cubre los trastornos alimentarios, la acumulación, la agorafobia, el evitar demandas y el problema de la doble empatía con más profundidad.

2. Cluster 1 — Perfiles neurodivergentes centrales

Autismo (fundacional, vínculo más fuerte)

El monotropismo fue *creado* para explicar rasgos autistas — intereses especiales intensos, necesidad de rutina (que protege el túnel de atención), y diferencias en la interacción social [1]. El MQ lo confirma empíricamente: los participantes autistas promediaron **4,15/5** frente a **3,19/5** para los no autistas ($n=1.110$) [2]. Este es el terreno nativo de la teoría y el vínculo mejor documentado.

TDAH (real y medido)

El TDAH eleva significativamente las puntuaciones de monotropismo ($\beta = +0,55$, $p<,001$) [2]. La conexión es conceptual además de estadística: la **hiperfocalización** del TDAH (Grotewiel et al., 2022, sobre la hiperfocalización como constructo distinto) es casi idéntica conceptualmente al túnel monotrópico, y la «disfunción ejecutiva» de activar la atención para tareas no interesantes es una predicción natural de un sistema tunelizado [2][6]. **Apoyado.**

AuDHD (la afirmación estelar está al revés) — *la corrección clave*

Afirmación verificada: «Las personas con un perfil AuDHD combinado puntúan lo más alto de todos los grupos en el MQ.»

Esto no es lo que muestran los datos. La regresión múltiple del artículo del MQ regresó el monotropismo sobre el estatus TDAH, el estatus autismo, y su **interacción** [2]:

Predictor (frente a ninguna condición)	β	p
TDAH, no autista	+0,55	<,001
Autista, no TDAH	+1,04	<,001
Interacción Autismo × TDAH	-0,43	<,001

El término de interacción es **negativo y significativo**. Los autores lo enuncian claramente: *«las puntuaciones de monotropismo no son tan altas para individuos autistas con TDAH como cabría esperar basándose en efectos puramente aditivos»* [2]. En otras palabras, añadir TDAH al autismo **no** empuja el monotropismo más alto de lo que el autismo solo predeciría — sale **más bajo** que la suma de los dos efectos independientes.

- El **grupo único que puntúa más alto** son las personas autistas (4,15); si la *media de celda* empírica para autista-con-TDAH se sitúa justo por encima o por debajo depende de la combinación exacta, pero la afirmación del encuadre de que AuDHD es *«el más alto de todos»* como efecto aditivo/super-aditivo está **sin apoyar y contradicha por la interacción**.
- La imagen *intuitiva* que ofrece el encuadre — «un tirón interno entre la necesidad autista de un túnel estable y profundo y el impulso TDAH de input novedoso» — es una descripción popular y fenomenológicamente resonante de la experiencia AuDHD, pero es **narrativa clínica/comunitaria, no un hallazgo de puntuación MQ**. Enúncielo como experiencia vivida, no como un resultado del MQ [6].

Afirmación corregida: *«Tanto el autismo como el TDAH elevan independientemente las puntuaciones de monotropismo, pero los dos interactúan de forma no aditiva: las personas autistas con TDAH puntúan más bajo en el MQ de lo que predeciría un modelo puramente aditivo — sugiriendo que las dos condiciones no simplemente se 'apilan' en la tendencia monotrópica.»* [2]

3. Cluster 2 — Rasgos cognitivos y de salud mental

Ansiedad y rumiación (asociación robusta, mecanismo plausible)

La ansiedad y la rumiación están elevadas en la población autista/TDAH, y el encuadre del monotropismo ofrece un mecanismo limpio: una mente tunelizada que se aferra a una preocupación la procesa en bucle («rumiación»), haciendo la ansiedad «pegajosa» [7][8]. La estructura de 8 factores del MQ incluso incluye una subescala de **«rumiación y ansiedad»**, mostrando que el cluster es empíricamente estrecho [2].

Apoyado — aunque note que la flecha causal (¿el monotropismo *produce* ansiedad, o comparte un sustrato con ella?) no está establecida.

TOC (solapamiento robusto, distinción importante)

El solapamiento autismo–TOC es real y replicado. Una metanálisis encuentra que aproximadamente **~17 % de las personas autistas cumplen criterios de TOC** (frente a ~1–2 % en la población general); la inversa también está elevada [9]. La distinción cualitativa que traza el encuadre es exactamente correcta y bien articulada: **los intereses monotrópicos son ego-sintónicos** (impulsados por la fascinación/alegría), mientras que **las compulsiones del TOC son ego-distónicas** (impulsadas por la angustia y realizadas para neutralizar el miedo) [10]. Esta distinción es clínicamente importante porque los dos pueden ser de otro modo difíciles de distinguir en la práctica. **Apoyado.**

Hiper-sistematización (constructo real, pero es de Baron-Cohen, no un hallazgo del monotropismo)

La «hiper-sistematización» — el impulso de analizar, construir y explorar sistemas — es un rasgo autista genuino y bien investigado, pero pertenece a la **teoría Empathizing–Systemizing (E-S)** de Simon Baron-Cohen, no al monotropismo [5]. Las dos teorías se solapan fuertemente (ambas describen un estilo cognitivo intenso y centrado en el detalle) y a veces se confunden, pero son **marcos distintos** con medidas distintas (el cociente EQ/SQ frente al MQ). El movimiento honesto: presente la hiper-sistematización como *consistente con* un estilo monotrópico (una mente tunelizada está bien dotada para dominar sistemas) mientras acredita la teoría E-S como algo propio [1][5].

4. Cluster 3 — Fenómenos neurológicos y de procesamiento

Problemas de permanencia del objeto ✗ (discutido — la segunda corrección clave)

Afirmación verificada: «Los individuos monotrópicos experimentan la permanencia del objeto de forma diferente ... el cerebro deja efectivamente de procesar su existencia hasta que algo exógenamente los retrae.»

Esta es la afirmación **más débil** del encuadre y necesita un manejo cuidadoso:

- Hay **una** fuente académica que propone un vínculo de permanencia del objeto: **Lawson & Dombroski (2017)**, que *plantea la hipótesis* de que una permanencia del objeto **retrasada** podría contribuir a algún estrés y ansiedad relacionados con el autismo [4]. Nota: es un artículo de construcción de hipótesis, no un estudio de confirmación.
- La literatura del desarrollo más amplia encuentra que la **permanencia del objeto básica es típicamente intacta o superior en el autismo**; las tareas piagetianas de permanencia del objeto se suelen superar a edades típicas [4].
- El fenómeno *real* que el encuadre busca — «fuera de la vista, fuera de la mente» para tareas, objetos e incluso personas — se explica mejor como un efecto de **memoria de trabajo / asignación de la atención**: una mente tunelizada no *falla* en representar el ítem, **falla en reorientar la atención de vuelta a él**. Eso es el monotropismo funcionando como se predice (un sistema tunelizado tiene pocos recursos libres para la reorientación periférica), no un déficit de permanencia del objeto [1][4].

Afirmación corregida: «La experiencia de 'fuera de la vista, fuera de la mente' en personas altamente monotrópicas se entiende mejor como un efecto de asignación de la atención / memoria de trabajo — la mente representa el ítem pero no se reorienta a él mientras está tunelizada — más que como un déficit en la permanencia del objeto (que es típicamente intacta en el autismo).» [1][4]

Desregulación sensorial / abrumamiento (mecanismo bien apoyado)

Esto está fuertemente apoyado. Como un sistema tunelizado gasta sus recursos centralmente, el input sensorial intrusivo repentino (sirena, luz, tacto) exige una reasignación costosa — experimentada como una «interrupción violenta». Esto se alinea con la literatura establecida de hiper-responsividad sensorial y la vía bien documentada desde la sobrecarga sensorial al **meltdown** (externalizante) y al **shutdown** (retirada internalizante), ambos reconocidos como respuestas involuntarias de abrumación [7][11]. El encuadre del monotropismo añade un *mecanismo* (coste de reasignación) a lo que de otro modo es un hallazgo descriptivo. **Apoyado.**

Inercia autista (real, cada vez más investigada)

La «dificultad profunda con las transiciones — problema para iniciar, detener o cambiar de dirección» es el constructo establecido de **inercia autista**: dificultad con la iniciación/terminación/cambio de tareas que «no está bajo control consciente», articulada primero en narrativas comunitarias autistas y ahora en trabajo revisado por pares [12][13]. Es conceptualmente la cara *conductual* del «coste de cambio» que captura el factor entorno-y-túnel del MQ [2]. **Apoyado** — y es el término técnico correcto (véase el brief complementario sobre puntuación/inercia).

5. Cluster 4 — Resultados de estrés crónico

Escisión monotrópica (correctamente atribuida a Adkin, pero dos significados se confunden)

Afirmación verificada: «La escisión monotrópica, acuñada por la practicante Tanya Adkin, ocurre cuando una mente monotrópica es forzada por su entorno a dividir su canal de foco único a través de múltiples flujos competidores.»

La **atribución es correcta**: la defensora autista **Tanya Adkin** acuñó «monotropic split», confirmado por múltiples fuentes comunitarias independientes [3]. Y la definición del encuadre aquí está **cerca del**

significado real de Adkin — el coste cognitivo/burnout que surge cuando una mente monotrópica es *forzada a «realizar politropía»* o dividir su atención a través de flujos competidores [3][14].

Dos advertencias:

1. **Es un concepto comunitario/practicante, no un constructo empíricamente validado.** «Monotropic split» aparece en la escritura comunidad-autista y clínica (p. ej. vía Neurodivergent Insights, Kelly Mahler, David Gray Hammond) pero **no tiene estudio de validación revisado por pares** tras él [3]. Trátelo como una *descripción* poderosa, válida por experiencia vivida, no una entidad medida.
2. **Dos cosas diferentes viajan bajo el nombre.** El sentido de Adkin = *realización politrópica forzada por una mente monotrópica* (un problema de ajuste ambiental). Un segundo sentido — usado en alguna escritura AuDHD — = *la competición interna entre una necesidad autista de un túnel estable y un impulso TDAH de novedad* (un problema de dinámica interna). El encuadre aquí describe el **primer** sentido (ambiental). Están relacionados pero son distintos; colapsarlos enturbia el concepto. (El brief paisajístico del proyecto usa «monotropic split» en el segundo sentido AuDHD — así que el término está genuinamente sobrecargado en el campo.) [3][6]

Enúncielo como: «El término 'escisión monotrópica' de la defensora autista Tanya Adkin describe el coste cognitivo y el burnout que surgen cuando una mente monotrópica es forzada a operar de forma politrópica — un poderoso concepto comunitario que aguarda validación formal.» [3]

Burnout  (constructo establecido; el vínculo con el monotropismo es heurístico)

El burnout autista es ahora un constructo bien definido: **agotamiento crónico, pérdida de habilidades y tolerancia reducida al estímulo**, conceptualizado como resultante de estrés vital crónico y «un desajuste de expectativas y capacidades» sin apoyo y recuperación adecuados (Raymaker et al., 2020; Higgins et al., 2021, un estudio Grounded-Delphi con expertos autistas) [15][16]. La vía del monotropismo hacia el burnout — transiciones forzadas constantes, enmascaramiento y «escisión monotrópica» drenando recursos sin tiempo de

recuperación/flujo — es **heurísticamente poderosa y validada por la comunidad**, pero la contribución *específica* de la ruptura del túnel al burnout (frente al enmascaramiento, el trauma, la carga sensorial, la demanda crónica) **no se ha aislado experimentalmente** [15]. **Apoyado como hipótesis fuerte, no como cadena causal establecida.**

6. Un marcador graduado

Afirmación en el encuadre	Veredicto	Nota
El monotropismo no tiene comorbilidades-enfermedad	✓ Correcto	Tiene asociaciones + mecanismos compartidos [1]
Autismo = vínculo primario	✓ Fundacional	MQ 4,15 vs 3,19 [2]
El TDAH eleva el monotropismo	✓ Apoyado	$\beta = +0,55$ [2]
AuDHD puntúa lo más alto de todos	✗ Al revés	La interacción es negativa ($\beta = -0,43$) [2]
Solapamiento ansiedad y rumiación	✓ Robusto	El MQ tiene un factor rumiación/ansiedad [2]
Solapamiento TOC (ego-sintónico vs distónico)	✓ Apoyado	~17 % de co-ocurrencia; distinción correcta [9][10]
Hiper-sistematización	⚠ Real pero mal etiquetado	Es la teoría E-S de Baron-Cohen, no el monotropismo [5]
Problemas de permanencia del objeto	✗ Discutido	1 artículo de hipótesis; la PO suele ser intacta; es asignación de atención [4]
Abrumamiento sensorial → meltdown/shutdown	✓ Bien apoyado	Mecanismo = coste de reasignación [7][11]
Inercia autista	✓ Real	Término correcto; revisado por pares [12][13]
Escisión monotrópica acuñada por Adkin	⚠ Atribución correcta; comunitario, no validado	Dos significados confundidos [3]

Afirmación en el encuadre	Veredicto	Nota
Burnout por transiciones forzadas + enmascaramiento	✓ Constructo establecido; vínculo heurístico	No aislado experimentalmente [15][16]

7. Conclusiones prácticas

- **Abra con el principio:** el monotropismo es un estilo atencional medible cuyos *solapamientos* con condiciones son asociaciones y mecanismos compartidos — nunca «causa X». [1]
- **Cite el MQ correctamente:** el autismo y el TDAH elevan cada uno las puntuaciones, pero la combinación es **no aditiva (más baja de lo esperado)** — no diga que AuDHD puntúa lo más alto [2].
- **Mantenga la distinción ego-sintónico/ego-distónico** al discutir TOC frente a intereses especiales — es clínicamente útil y correctamente encuadrada [10].
- **Acredite los marcos con precisión:** la hiper-sistematización = teoría E-S de Baron-Cohen; la escisión monotrópica = concepto comunitario de Adkin (sentido ambiental de politropía forzada); la inercia autista = el constructo revisado por pares de dificultad de transición [3][5][12].
- **Suelte «el déficit de permanencia del objeto»:** reencadre como asignación de atención / memoria de trabajo, que es tanto preciso como más útil para el apoyo [1][4].
- **Distinga validado vs heurístico:** el burnout es un constructo establecido, pero la vía monotropismo→burnout es una hipótesis fuerte, no un efecto medido; la «escisión monotrópica» es válida por experiencia vivida pero no validada [3][15].

Fuentes

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. *Autism*, 9(2), 139–156.
doi:10.1177/1362361305051398 — origen del monotropismo; una diferencia en la asignación de recursos (un continuo), no un déficit.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

[2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (autoinforme de 47 ítems; preprint de validación). Open Science Framework. — n=1.110; media autista 4,15 (DE ,347) vs no autista 3,19 (DE ,578); regresión $\beta(\text{TDAH})=+0,55$, $\beta(\text{autismo})=+1,04$, **$\beta(\text{interacción})=-0,43$, $p<,001$** ; la interacción TDAH+autismo es *sub-aditiva*; estructura de 8 factores incl. factores rumiación/ansiedad y entorno/túnel. <https://osf.io/wpx5g> · validación: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Archivo local: [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](#)

[3] Adkin, T. — «monotropic split» (defensora autista / practicante; concepto comunitario). Confirmado vía múltiples fuentes comunitarias independientes: Neurodivergent Insights (glosario), Kelly Mahler (entrada invitada), David Gray Hammond, Jade Farrington («Cuando personas monotrópicas son forzadas a operar de forma politrópica se conoce como escisión monotrópica»). Definición: el coste cognitivo/burnout de forzar una mente monotrópica a «realizar politropía». Concepto comunitario/practicante — **sin estudio de validación revisado por pares**. <https://jade-farrington.medium.com/what-is-monotropic-split-1c7c46fd9017> · <https://www.kelly-mahler.com/what-is-interoception/interoception-and-monotropism>

[4] Lawson, W. & Dombroski, B. (2017). *Problems with Object Permanence: Rethinking Traditional Beliefs Associated with Poor Theory of Mind in Autism*. J. Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 5(1). doi:10.6000/2292-2598.2017.05.01.1 — *plantea la hipótesis* de una permanencia del objeto **retrasada** como contribuyente a algún estrés relacionado con el autismo (un artículo de construcción de hipótesis, no una confirmación). Literatura más amplia: la permanencia del objeto es típicamente intacta/superior en el autismo; «fuera de la vista, fuera de la mente» se lee mejor como asignación de atención/memoria de trabajo. Archivo local: [sources/12-object-permanence-lawson-dombroski.pdf](#) · <https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/4562>

[5] Baron-Cohen, S. (2009/2010). *Autism and the empathizing–systemizing (E-S) theory; the hyper-systemizing theory of autism*. Annals of the NYAS; APA PsycNet. — la hiper-sistematización y la teoría E-S son el marco de Baron-Cohen, medido vía el cociente EQ/SQ; distinto del (aunque

solapado con) monotropismo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Empathising%E2%80%93systemising_theory · revisión: Greenberg & Baron-Cohen, *Empathizing-Systemizing Theory: Past, Present, and Future*.

[6] Autistic Scholar — «*Revisiting monotropism*» (AuDHD como túneles competidores/inestables; referencias Grotewiel et al. 2022 sobre hiperfocalización del TDAH como constructo distinto). Cuenta fenomenológica/comunitaria, no un hallazgo de puntuación MQ. Archivo local: <sources/13-revisiting-monotropism-autisticscholar.html> · <https://www.autisticscholar.com/monotropism>

[7] Green, S. A. & Ben-Sasson, A. (2010). *Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship?* J. Autism and Developmental Disorders. PMC2980623 — hiper-responsividad sensorial, condicionamiento de contexto y la vía de abrumación. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623>

[8] Oakley, B. et al. / literatura de ansiedad en autismo — ansiedad y rumiación elevadas en la población autista/TDAH (citada vía el brief paisajístico de comorbilidad del proyecto para el sustrato de ansiedad).

[9] Meier, S. M. et al. / metanálisis de la concordancia autismo–TOC — ~17 % de las personas autistas cumplen criterios de TOC (frente a ~1–2 % población general); ~17 % de niños con TOC muestran síntomas autistas leves. Resumido vía Move Up ABA citando investigación de 2015 y el resumen The Transmitter/Spectrum. <https://www.thetransmitter.org/spectrum/sweeping-study-underscores-autisms-overlap-with-obsessions> · metanálisis autismo↔TOC: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11048346>

[10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). *"Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours* (cualitativo). PMC11497754 — la distinción ego-sintónico (intereses) vs ego-distónico (compulsiones). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754>

[11] Autism Society (2025). *Autistic Meltdowns and Shutdowns* — meltdown (externalizante) y shutdown (retirada internalizante) como respuestas involuntarias a estrés/input sensorial abrumador. https://autismsociety.org/wp-content/uploads/2025/07/AutismSociety_Autistic-Meltdowns-Shutdowns_2025-06V2F_Digital.pdf

- [12] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia* (preprint/cualitativo). doi:10.31234/osf.io/ahk6x — dificultad para iniciar, detener y cambiar tareas «no bajo control consciente». Archivo local: `sources/11-autistic-inertia-osf.pdf` · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x>
- [13] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer — inercia autista: originada en la comunidad, ahora revisada por pares; cita Carls-Diamante & Laciny 2024, Greaves-Lord et al. 2023, Buckle 2021, Heasman 2024, Rapaport 2024. <https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>
- [14] Neurodivergent Insights — *Monotropism* (glosario) y *ADHD vs Autism vs OCD* (solapamiento triple). Recurso comunitario/clínico que enmarca la escisión monotrópica y los solapamientos. <https://neurodivergentinsights.com/glossary/monotropism> · <https://neurodivergentinsights.com/adhd-vs-autism-vs-ocd>
- [15] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143. doi:10.1089/aut.2019.0079 — agotamiento crónico, pérdida de habilidades, tolerancia reducida al estímulo; por estrés vital crónico y desajuste de expectativas y capacidades. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378
- [16] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating #AutisticBurnout*. Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 — definición de consenso: agotamiento, retirada, problemas de cognición, habilidades de vida diaria reducidas, aumento de rasgos autistas. <https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>
-

Complemento del brief paisajístico más completo del proyecto:
`outputs/monotropism-comorbidity-landscape.md` (que cubre los trastornos alimentarios, la acumulación, la agorafobia, el evitar

demandas/PDA y el problema de la doble empatía). Este brief se centra en verificar el encuadre de cuatro clusters de arriba y no repite ese material.